UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH UP UNIVERSITÉ **RECONNUE PAR L'ÉTAT** جامعة معترف بها من طرف الدولة	**Année universitaire :** 2021-2022 **Niveau : 4ème année** **Examens Session Normale (Mai 2022)**	FPMM FACULTÉ PRIVÉE DE MÉDECINE DE MARRAKECH UNIVERSITÉ PRIVÉE DE MARRAKECH
Semestre : S8	**Module : Appareil locomoteur** **Durée : 01 Heure** **Enseignant : Pr. Niamane (Coordinateur)**	

TRAUMATO-ORTHOPEDIE : 1 à 20 – RHUMATOLOGIE : 21 à 40 - MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION : 41 à 50.

Vous êtes interne de garde aux urgences ; vous recevez une dame de 65 ans diabétique qui a des douleurs du membre supérieur droit. L'examen initial retrouve une patiente consciente sans signes de détresse cardio respiratoire, qui se plaint de douleurs au niveau de la main s'étendant à l'avant-bras avec la notion d'une plaie par objet tranchant de l'index survenu il y a quelques jours. L'inspection retrouve un membre tuméfié avec impotence fonctionnelle. La patiente se plaint aussi d'asthénie et d'insomnie. **[QCM 1 à 5]**

1- Si vous suspectez une infection. Quels sont les éléments que vous devez rechercher pour compléter votre examen clinique.

A. Une déformation du membre
B. Une porte d'entrée
C. Une chaleur locale
D. Le dosage de la CRP
E. Prise de la température

Après une radiographie normale ; vous concluez à une contusion et prescrivez un antalgique et un AINS et renvoyez la patiente chez elle. Quarante-huit heures (48h) après, la patiente est réadmise pour malaise et aggravation de la douleur qui prend tout le membre. L'examen général retrouve une patiente à l'état général altéré, avec un état de choc. L'examen local du membre trouve des placards echymo-nécrotiques avec une peau insensible dans certaines zones. Le diagnostic de fasciite nécrosante a été retenu.

2-Quels sont les éléments en faveurs de ce diagnostic.

A. L'âge
B. Le diabète
C. Le placard echymo-nécrotique
D. L'état de choc
E. La prise d'AINS

3-Quelle(s) est la conduite thérapeutique chez cette patiente ?

A. Une antibiothérapie avec mesures de réanimation seule
B. Une excision large des tissus nécrosés
C. Admission en milieu de réanimation
D. L'amputation d'emblée
E. Un drainage chirurgical

4-Quelle est la complication redoutable que risque cette patiente ?

A. L'amputation
B. L'extension de la nécrose
C. La myonecrose
D. Le décès
E. La perte de la fonction du membre

5- A posteriori ; des erreurs ont été commises lors de la première consultation. Lesquelles ?

A. Un Examen clinique insuffisant
B. Renvoyer la patiente chez elle
C. Demander une radiographie
D. Prescrire des AINS
E. Donner des antalgiques

6- Cochez le ou les réponses exactes concernant les fractures de l'avant-bras :

A. Le cal vicieux en baïonnette est mieux toléré que le cal vicieux angulaire
B. Le cal vicieux en baïonnette gène la pronosupination
C. La pseudarthrose est une complication exceptionnelle
D. La synostose radio ulnaire est une complication précoce
E. L'un des buts du traitement est la restitution de la courbure pronatrice du radius

7- La luxation postérieure de l'épaule :

A. Est la forme de luxation la plus fréquente.
B. Est secondaire à un mécanisme en abduction et rotation externe.
C. Est caractérisée par une attitude et rotation interne fixée.
D. Nécessite toujours une TDM pour son diagnostic.
E. Son traitement est toujours chirurgical.

8- Les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus :

A. Sont plus fréquentes chez le sujet jeune.
B. Sont favorisés par l'ostéoporose.
C. Peuvent être associées à une luxation de l'épaule.
D. Exposent au risque de raideur de l'épaule.
E. Leur traitement est toujours chirurgical.

9- Les complications possibles au niveau d'un plâtre circulaire pour fracture diaphysaire fermée d'un membre sont :

A. Syndrome des loges
B. Phlébite.
C. Infection.
D. Escarre cutanée.
E. Déplacement secondaire.

10- Les fractures ouvertes de jambe :

A. Sont fréquentes au niveau du fémur.
B. Exposent au risque d'infection.
C. Nécessitent toujours un parage en urgence.
D. Nécessitent la mise en place d'une antibiothérapie curative.
E. Nécessitent toujours la mise en place d'un fixateur externe.

11- Les tumeurs osseuses malignes primitives :

A. Sont très fréquentes parmi les tumeurs de l'organisme.
B. Touchent exclusivement l'adulte après 45 ans.
C. Se définissent par le tissu osseux où elles se développent.
D. Entrainent une lyse osseuse avec des limites condensées.
E. Nécessitent une prise en charge multi disciplinaire.

12- L'entorse de la métacarpo-phalangienne du pouce :

A. Est une lésion fréquente.
B. Intéresse le ligament latéral externe.
C. Nécessite la pratique de cliches dynamiques.
D. Peut entrainer des séquelles graves si elle est méconnue.
E. Nécessite un traitement chirurgical en cas d'effet STENER.

13- La triade diagnostique d'une tendinopathie comporte :

A. Douleur à la palpation du tendon
B. Douleur musculaire
C. Douleur à l'étirement du tendon
D. Douleur à la contraction résistée
E. Aucune réponse juste

14- Parmi ces tests, lesquels explorent les lésions méniscales :

A. Le test de Skinner
B. Le scotch test
C. Le grinding test d'Appley
D. Le test de NEER
E. Le test de Brunet Guedj

15- Les signes de gravité d'une lésion musculaire sont :

A. La perception d'un craquement
B. L'impotence fonctionnelle totale objective et immédiate
C. L'installation rapide de l'œdème
D. La reprise rapide du sport
E. Aucune réponse juste

16- Devant une luxation du genou, il faut rechercher impérativement :

A. Une lésion du nerf crural
B. Une fracture de Hoffa
C. Une lésion de l'artère poplitée
D. Une rupture du tendon calcanéen
E. Aucune réponse n'est juste

17- L'avalement de la tubérosité tibiale antérieure du genou (recul de la TTA) témoigne de la lésion du :

A. Ligament poplité
B. Ligament latéral interne
C. Ligament croisé antéro latéral
D. Ligament croisé postéro médial
E. Aucune réponse juste

Un patient âgé de 75 ans présente suite à une chute de sa hauteur un traumatisme de la hanche droite occasionnant douleur et impotence fonctionnelle. [QCM 18 à 20]

18- Les deux diagnostics les plus probables sont :

A. Fracture du col du fémur
B. Fracture du rachis lombaire
C. Fracture du massif trochantérien
D. Fracture de rein
E. Aucune réponse juste

19- Le patient n'arrive pas à décoller son talent du plan du lit. Ce signe clinique s'appelle :

A. Le signe talo-crural
B. Le signe du glaçon
C. La talalgie
D. Le signe clino-statique
E. Aucune réponse juste

20- La palpation révèle une douleur du pli de l'aine et un massif trochantérien indolore. Le diagnostic le plus probable est :

A. La fracture du col du fémur
B. La fracture du rachis lombaire
C. La fracture du massif trochantérien
D. La fracture de rein
E. Aucune réponse juste

21. Au cours de la spondyloarthrite, l'atteinte oculaire :

A. Est une uvéite antérieure
B. Est une uvéite granulomatose
C. Peut-être révélatrice de la maladie
D. Est responsable d'un œil rouge douloureux
E. Entraine un risque de cécité

22. Le diagnostic de spondyloarthrite doit être évoqué devant :

A. Un sujet âgé
B. Des rachialgies d'horaire inflammatoire
C. Des douleurs fessières á bascule
D. Une oligoarthrite asymétrique
E. Des enthésopathies

23. La goutte :

A. Est secondaire à une hyper uricémie > à 60 mg/l
B. Siege préférentiellement sur l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil
C. Est associé à un risque cardiovasculaire élevé
D. Nécessite un traitement à vie
E. Est une conséquence inéluctable de l'hyper uricémie

24. Parmi les règles hygiéno-diététiques au cours de la goutte, on cite :

A. Cure d'amaigrissement en cas d'obésité
B. Arrêt des boissons alcoolisées
C. Eviction des viandes rouges
D. Restrictions des apports hydriques
E. Alcalinisation des urines

25. Quels sont les facteurs favorisants la tuberculose ostéo-articulaire ?

A. La malnutrition
B. Le diabète
C. L'âge avancé
D. Les traumatismes ostéo-articulaires
E. L'antécédent de contage tuberculeux

26. Quelles sont les affections nécessitant une hospitalisation en urgence

A. Arthrite septique à bactérie pyogène
B. Arthrite goutteuse
C. Connectivite avec atteinte viscérale grave
D. Artérite giganto-cellulaire
E. Vascularite systémique associée aux ANCA

27. La fièvre peut être retrouvée dans ces affections sauf une, laquelle ?

A. Poussée congestive d'arthrose
B. Accès de goutte
C. Polyarthrite rhumatoïde
D. Maladie de Still de l'adulte
E. Artérite giganto-cellulaire

28. Au cours de la polyarthrite rhumatoïde, la corticothérapie par voie intraveineuse :

A. Est indiquée en cas de poussée polyarticulaire majeure
B. Utilise la Méthylprednisolone (Solumedrol*)
C. Nécessite un dosage de la kaliémie lors du bilan initial
D. Est sans danger
E. Nécessite la réalisation d'un ECG lors du bilan initial

29. Le traitement de fond de la polyarthrite rhumatoïde :

A. Permet le contrôle de la maladie
B. A une action immunomodulatrice
C. A un effet immédiat
D. Inclue le méthotrexate
E. Inclue les anti TNF alpha

30-La ponction du coude chez un jeune patient ramène un liquide trouble, contenant 75000 globules blancs/mm3 et quelques Cocci Gram négatifs. Parmi les diagnostics suivants, lequel est à envisager ?

A. Arthrose
B. Arthrite septique à staphylocoque
C. Arthrite tuberculeuse
D. Une crise de goutte
E. Arthrite septique à gonocoque

31-Madame X a une douleur inflammatoire de la hanche droite depuis 6 mois. Le bilan est en faveur d'une infection articulaire. Quel est le germe habituellement responsable de ce tableau clinique ?

A. Le staphylocoque aureus.
B. La tuberculose.
C. Le pneumocoque.
D. Les bacilles gram négatif.
E. Le gonocoque.

32-Lors de l'examen d'une épaule douloureuse, la manœuvre de Neer positive, oriente vers :

A. Une rupture du tendon sus-épineux.
B. Une tendinopathie du sous-scapulaire.
C. Un conflit sous acromial.
D. Une tendinopathie du sous-épineux.
E. Une capsulite rétractile.

33-Un malade consulte pour une boiterie. On peut retenir le diagnostic de coxite chronique devant l'une des affections suivantes :

A. Une synovite villo-nodullaire.
B. Une spondylarthrite.
C. Une coxarthrose.
D. Une ostéonécrose de la tête fémorale.
E. Une algodystrophie de la hanche.

34-Une lombo-cruralgie L3 comporte :

A. Une hypoesthésie à la face postérieure de la cuisse.
B. Une douleur du mollet.
C. Une radiculalgie qui se termine sur la face antérieure de la cuisse.
D. Une abolition du reflexe achilléen.
E. Une hypoesthésie du gros orteil.

35-Madame Y, âgée de 50 ans souffre de sa cheville droite depuis 20 jours. Elle avait fait deux mois auparavant une entorse bénigne qui a guéri. La cheville est actuellement tuméfiée, rouge et chaude. En faveur du diagnostic d'algodystrophie, on retient :

A. Une VS à 100 mm à la première heure.
B. Une déminéralisation mouchetée de la cheville.
C. Une CRP à 100 mg/l.
D. Une fièvre à 39,5 C.
E. Un aspect rouge et tuméfié de la cheville et du dos du pied.

36-Concernant le syndrome du canal carpien :

A. La cause idiopathique représente 50 % des cas.
B. La forme sensitive est la plus fréquente.
C. Le signe de TINEL reproduit les symptômes par la flexion forcée du poignet pendant 30 à 60 secondes.
D. L'EMG peut être normal.
E. Le traitement est exclusivement chirurgical.

37-A l'origine d'une hypercalcémie égale ou supérieure à 3 mmoles/l, les cancers occupent :

A. La première place
B. La deuxième place
C. La troisième place
D. La quatrième place
E. La cinquième place

38-La lésion le plus souvent trouvée à l'origine de l'hyperparathyroïdie primaire est :

A. Un cancer parathyroïdien
B. Un adénome bénin
C. Une hyperplasie des parathyroïdes
D. Une tumeur hypophysaire bénigne
E. Aucune des propositions

39-La lombosciatique L5 commune se caractérise par :

A. Une lombalgie inflammatoire.
B. Une lombalgie mécanique.
C. Une radiculalgie qui se termine au niveau du gros orteil.
D. Une radiculalgie qui se termine au niveau de la plante du pied.
E. La présence toujours d'une hernie discale

40- Concernant l'arthrose :

A. La douleur est de rythme mécanique.
B. Les radiographies mettent en évidence des ostéophytes.
C. Il existe un syndrome inflammatoire biologique.
D. L'étude du liquide articulaire note moins de 1000 globules blancs/mm3.
E. Le traitement est exclusivement chirurgical.

41. Les muscles les plus affectés par les lésions musculaires sont :

A. Adducteurs
B. Moyen fessier
C. Ischio-jambier
D. Quadriceps
E. Gastrocnémiens

42. Concernant la marche normale de l'Homme :

A. Elle est automatique
B. A un certain moment, les deux pieds sont décollés en même temps
C. Elle est volontaire
D. Elle est reflexe
E. Elle est acquise à partir de 18 mois de vie

43. Concernant la paralysie cérébrale :

A. C'est la première cause de handicap moteur chez l'enfant
B. Elle est liée à une lésion sur un cerveau mature
C. Elle est liée à une lésion évolutive
D. Nécessite une prise en charge multidisciplinaire
E. Entraine uniquement des déficiences motrices

44. Parmi les propositions suivantes, lesquelles caractérisent la sédentarité ?

A. Avoir un emploi assis
B. Passer 4 heures devant les écrans
C. Prendre les escalators à la place des escaliers
D. Faire du jardinage à la place d'une heure de course à pied
E. Pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique modérée par semaine

45. Concernant les prothèses :

A. Peuvent être internes ou externes
B. Leur bon usage nécessite une rééducation associée et adaptée.
C. Sujettes à une prescription spécialisée
D. L'emboîture est faite sur mesure
E. Sont fabriquées par les podologues

Une patiente de 65 ans souffre de son genou droit. Vous diagnostiquez, chez elle, une gonarthrose droite modérée. **[QCM 46 à 50]**

46. Les déficiences possibles chez cette patiente sont :

A. La douleur
B. Le flessum
C. La faiblesse du quadriceps
D. La difficulté à marcher
E. La difficulté à monter et descendre les escaliers

47. Les limitations d'activité possibles chez cette patiente :

A. La difficulté à marcher
B. La difficulté à monter et descendre les escaliers
C. La difficulté à aller à la mosquée
D. La difficulté à faire ses courses
E. L'épanchement articulaire

48. Les restrictions de participation possible chez cette patiente :

A. La difficulté à promener son petit enfant
B. La difficulté à faire ses courses
C. La difficulté à garder la position debout
D. Le craquement articulaire
E. La limitation articulaire

49. Pour complément de prise en charge, vous adressez cette patiente chez :

A. Le kinésithérapeute
B. L'ergothérapeute
C. L'orthophoniste
D. Le podologue
E. L'orthoprothésiste

50. Quel type d'aides techniques allez-vous lui prescrire :

A. Un cadre de marche
B. Un déambulateur
C. Une canne à porter à droite
D. Une canne à porter à gauche
E. Un fauteuil roulant

Code candidat

Nom

Prénom

CORRECTION

Remarques :

Université Privée de Marrakech
Faculté Privée de Médecine de Marrakech
Année Universitaire : 2021-2022

MED4E19 Rhumatologie 2021-2022
MED4E17 Traumato-Orthopédie 2021-2022
MED4E18 Réadaptation fonctionnelle 2021-2022

Maladies de l'appareil locomoteur
NIAMANE Radouane

	A	B	C	D	E
Q1	☐	☒	☒	☐	☒
Q2	☒	☒	☒	☒	☒
Q3	☐	☒	☒	☐	☐
Q4	☐	☐	☐	☒	☐
Q5	☒	☒	☐	☒	☐
Q6	☒	☐	☐	☐	☒
Q7	☐	☐	☒	☐	☐
Q8	☐	☒	☒	☒	☐
Q9	☒	☒	☐	☒	☒
Q10	☐	☒	☒	☒	☐
Q11	☐	☐	☐	☐	☒
Q12	☒	☐	☒	☒	☒
Q13	☒	☐	☒	☒	☐
Q14	☐	☐	☒	☐	☒
Q15	☒	☒	☒	☐	☐
Q16	☐	☐	☒	☐	☐
Q17	☐	☐	☐	☒	☐
Q18	☒	☐	☒	☐	☐
Q19	☐	☐	☐	☒	☐
Q20	☒	☐	☐	☐	☐
Q21	☒	☐	☒	☒	☒
Q22	☐	☒	☒	☒	☒
Q23	☒	☒	☒	☒	☐
Q24	☒	☒	☒	☐	☒
Q25	☒	☒	☒	☐	☒

	A	B	C	D	E
Q26	☒	☐	☒	☒	☒
Q27	☒	☐	☐	☐	☐
Q28	☒	☒	☒	☐	☒
Q29	☒	☒	☐	☒	☒
Q30	☐	☐	☐	☐	☒
Q31	☐	☒	☐	☐	☐
Q32	☐	☐	☒	☐	☐
Q33	☐	☒	☐	☐	☐
Q34	☐	☐	☒	☐	☐
Q35	☐	☒	☐	☐	☒
Q36	☒	☒	☐	☒	☐
Q37	☒	☐	☐	☐	☐
Q38	☐	☒	☐	☐	☐
Q39	☐	☒	☒	☐	☐
Q40	☒	☒	☐	☒	☐
Q41	☐	☐	☒	☒	☒
Q42	☒	☐	☒	☒	☐
Q43	☒	☐	☐	☒	☐
Q44	☒	☒	☒	☐	☐
Q45	☒	☒	☒	☒	☐
Q46	☒	☒	☒	☐	☐
Q47	☒	☒	☐	☐	☐
Q48	☒	☒	☐	☐	☐
Q49	☒	☐	☐	☐	☐
Q50	☐	☐	☐	☒	☐